

• 指南解读 •



扫一扫下载指南全文

2019 年《OARSI 非手术治疗膝、髋及多关节骨关节炎临床实践指南》方法学解读和推荐意见阐释



邢丹^{1,2#}, 陈耀龙^{3,4,5#}, 曾宪涛⁶, 周奇^{3,4,5}, 李志昌^{1,2}, 靳英辉⁶, 杨楠^{3,4,5}, 赵嘉国⁷, 王斌⁸, 付维力⁹, 杜亮¹⁰, 林剑浩^{1,2}

1. 北京大学人民医院骨关节科 (北京 100044)
2. 北京大学关节病研究所 (北京 100044)
3. 兰州大学基础医学院循证医学中心 (兰州 730000)
4. 世界卫生组织指南实施与知识转化合作中心 (兰州 730000)
5. GRADE 中国中心 (兰州 730000)
6. 武汉大学循证与转化医学中心 (武汉 430071)
7. 天津市天津医院 (天津 300211)
8. 山西医科大学第二医院骨科 (太原 030002)
9. 四川大学华西医院骨科 (成都 610041)
10. 四川大学华西医院循证医学中心 (成都 610041)

【摘要】 2019 年国际骨关节炎学会 (osteoarthritis research society international, OARSI) 发布的《非手术治疗膝、髋及多关节骨关节炎临床实践指南》涉及膝关节、髋关节及多关节骨关节炎 (osteoarthritis, OA) 非手术治疗相关的多项干预措施。与国内的关节炎诊疗共识相比, OARSI 制订的这部指南在方法学的选择和推荐意见的提出方面存在一定的优势且具有很好的代表性。因此, 我们对该指南进行解读, 以期达到最终目的: 加强国内医师对 OA 非手术治疗的规范和理解; 加强 OA 临床实践者对本指南制订方法学的理解, 从而更好地结合推荐意见和证据开展临床实践和加快指南的实施; 加快指南制订方法学在我国的传播, 帮助临床工作者理解指南的内涵和价值; 为制订基于我国现状的、涉及其他临床学科的临床实践指南提供方法学指引和参考。

【关键词】 临床实践指南; 指南解读; 骨性关节炎; 方法学

OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis: a methodological interpretation and recommendations explanation

XING Dan^{1,2}, CHEN Yaolong^{3,4,5}, ZENG Xiantao⁶, ZHOU Qi^{3,4,5}, LI Zhichang^{1,2}, JIN Yinghui⁶, YANG Nan^{3,4,5}, ZHAO Jiaguo⁷, WANG Bin⁸, FU Weili⁹, DU Liang¹⁰, LIN Jianhao^{1,2}

1. Arthritis Clinic & Research Center, Peking University People's Hospital, Peking University, Beijing, 100044, P.R.China
2. Arthritis Institute, Peking University, Beijing, 100044, P.R.China
3. Evidence-Based Medicine Center, School of Basic Medical Sciences, Lanzhou University, Lanzhou, 730000, P.R.China
4. WHO Collaborating Centre for Guideline Implementation and Knowledge Translation, Lanzhou, 730000, P.R.China
5. Chinese GRADE Center, Lanzhou, 730000, P.R.China
6. Center for Evidence-Based and Translational Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, 430071, P.R.China
7. Department of Orthopedics, Tianjin Hospital, Tianjin, 300211, P.R.China
8. Department of Orthopaedics, The Second Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan, 030002, P.R.China
9. Department of Orthopedics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, 610041, P.R.China
10. Chinese Evidence-Based Medicine Center, Sichuan University, Chengdu, 610041, P.R.China

Corresponding author: DU Liang, Email: dul@cjebm.org.cn; LIN Jianhao, Email: linjianhao@pkuph.edu.cn

DOI: 10.7507/1672-2531.201909136

基金项目: 国家自然科学基金项目 (编号: 81973606、81802204、81501919); 北京大学人民医院研究与发展基金项目 (编号: RDY2019-11、RS2019-03); 北京市科技计划重大专项 (编号: Z181100001818008)

通信作者: 杜亮, Email: dul@cjebm.org.cn; 林剑浩, Email: linjianhao@pkuph.edu.cn

#共同第一作者



【Abstract】 Osteoarthritis research society international (OARSI) guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis in 2019 contained some recommendations in treating patients with osteoarthritis (OA) who are considering non-surgical treatment. Compared with domestic consensus on diagnosis and treatment for OA, this clinical practice guideline (CPG) prepared by OARSI had some advantages in terms of methodology selection and recommendation. Therefore, it is necessary to interpret this CPG to accelerate the understanding and dissemination of the CPG. The ultimate aims were: to strengthen the normative and understanding of non-surgical treatment of OA; to enhance the understanding of clinicians for this CPG in treating OA; to accelerate the development of guideline development methodologies in China; to provide methodological guidance for the development of CPG based on the current situation in China.

【Key words】 Clinical practice guideline; Guideline interpretation; Osteoarthritis; Methodology

1 指南解读原因和解读者

1.1 指南解读原因

国际骨关节炎学会 (osteoarthritis research society international, OARSI) 作为骨关节炎 (osteoarthritis, OA) 领域有国际影响力的专业学会组织, 近年来发布了一系列关于 OA 诊治方面的临床实践指南^[1,2], 包括多部非手术治疗 OA 指南。本文解读的《OARSI 非手术治疗膝、髋及多关节骨关节炎临床实践指南》(以下简称“指南”)^[3]是对前两部指南^[1,2]的更新。虽然目前的指南制订机构已经将循证医学方法作为指南制订的基本方法, 但不同指南制订机构在指南制订方法学的选择及指南更新的方法学方面存在差异。因此, 有必要以该指南为例, 对 OARSI 在最新指南制订方法学层面的特点和变化进行解读, 并对指南的临床推荐意见进行简要阐释。

1.2 解读者

由 OA 专业临床医生、循证医学方法学专家及指南制订方法学专家组成的研究团队对指南进行解读。

1.3 联系原制订者

本指南解读过程未与原制订者联系, 因该指南的原文和补充文件足够详实。

1.4 利益冲突

参与指南解读的人员不存在与该指南相关的学术或商业利益冲突。

2 背景

2.1 版本和年代

该指南是 OARSI 针对 OA 的两部非手术治疗临床实践指南^[1,2]的更新。OARSI 从 2016 年初开始准备制订指南, 最终的指南全文发表于 2019 年 7 月, 用时约 3 年时间。

2.2 来源

该指南全文于 2019 年 7 月发表于 *Osteoarthritis*

and Cartilage 上。指南相关的补充文件也发表在同期杂志附录中。

2.3 制订机构和指南工作组的构成

指南由 OARSI 发起, 多学科专家共同参与, 可以在一定程度上减少人员偏倚和利益冲突。OARSI 要求所有参与指南制订的人员进行利益冲突声明。指南工作组由 4 部分构成: ① 指南核心小组; ② 文献综述小组; ③ 投票小组; ④ 患者小组。

参加人员的专业背景多样化, 可以为指南推荐意见的形成提供人员基础, 从而使该指南尽可能包括更多、更广泛的临床问题。患者参与指南的制订, 更能够体现以患者为中心的思想, 从而提高指南的实用性。

2.4 制订背景

OA 好发于中老年人, 65 岁以上中老年人群超过一半为 OA 患者^[4]。无论是西方国家还是我国, 膝 OA 的患病率都较高^[5-7]。膝、髋 OA 在全球慢性疼痛和功能障碍的原因排名中位于前列^[8]。另外, OA 还会增加社会经济负担和人群的疾病负担, 从而最终影响社会生产力和个人的劳动能力^[9-13]。OARSI 在 2008 年和 2014 年分别针对髋膝关节和膝关节 OA 发布了指南。此次更新, 一方面突出了以患者为中心的优势, 一方面根据 OA 常见合并症针对亚组人群进行不同治疗推荐, 最后以临床路径图的方式增加了指南的实用性。

2.5 目标人群

使用者主要包括参与 OA 治疗的医生 (骨科、风湿科、康复科等)、临床决策者、其他临床实践指南和推荐意见制订者。尽管指南正文中没有详细阐明指南的目标人群, 但从指南小组的构成以及制订机构的责任可以推测出目标人群的范围。

2.6 适用范围

该指南旨在规范膝、髋及多关节 OA 非手术治疗相关的临床问题, 并指导上述领域相关的临床实践。因此, 该指南的使用环境包括了膝、髋以及多

关节 OA 非手术相关的临床情景。笔者认为,该指南规范的干预措施针对的是 OA 非手术相关的内容,因此对于使用指南的医疗机构级别未做限定,即所有涉及非手术相关诊疗的医疗机构均在指南的适用范围内。

3 制订方法

3.1 指南工作组的职责和临床问题的确定

3.1.1 指南工作组的职责 ① 指南核心小组:由临床医生和方法学家组成,主要负责项目的设计、定义指南的科学范围、起草指南、反馈证据评价结果等;② 文献综述小组:由循证医学、系统评价、指南领域的方法学家组成,主要开展证据检索和评价、证据体质量评价、制作证据总结表并起草指南等;③ 投票小组:由多学科的临床医生或药师组成,主要负责参与问卷调研和咨询;④ 患者小组:由3名患者组成,主要负责根据临床调研结果发表评论。

3.1.2 临床问题的确定 首先由指南核心小组确定临床问题,并按照 PICO 原则解析每个临床问题。本指南针对膝 OA 定义了 67 个临床问题,针对髌 OA 定义了 60 个临床问题。之后文献综述小组按照既定的检索策略检索 PICO 问题相关的文献。由指南核心小组根据 GRADE 评价体系事先明确结局指标的重要性程度,然后进一步在每个 PICO 问题中明确既定的结局指标以及结局指标的重要性程度。由文献综述小组对检索到的相关题目、摘要以及全文进行评价和分析,提取并合成相关的数据。

3.2 证据的收集和分析

检索年限从建库至 2017 年 12 月,该指南制订者检索了 Medline、PubMed、EMbase、Google Scholar 及 The Cochrane Central Register of Controlled Trials 数据库。在纳入标准中,强调纳入研究类型为 RCT、系统评价和 Meta 分析,并进一步手工检索最新发表的系统评价和 Meta 分析中的参考文献及综述 2017 年 12 月之前发布的 OARSI 指南、ACR 指南和 EULAR 指南。

使用 Cochrane 协作网的偏倚风险评价工具对纳入的原始研究进行偏倚风险评价。使用 RevMan 软件进行 Meta 分析,对连续性变量和分类变量进行合并以及异质性分析。通过排除“最低质量的研究”进行敏感性分析。

3.3 证据分级方法

该指南严格按照 GRADE 方法进行制订,临床决策过程公开透明,通过匿名投票的方式进行。证据体的质量分级按照 GRADE 标准进行降级(发表偏倚、不一致性、不精确性、间接性)。将 RevMan 中合并分析 Meta 的结果导入到 GRADEpro 中,在线生成证据总结表。

3.4 共识形成和推荐方法

该指南在形成推荐方向和推荐强度时,采用了 GRADE 推荐的方法^[14]。总推荐级别包括:1A、1B、2、3、4A、4B 和 5。推荐方向包括:支持和反对。推荐强度包括:强推荐和弱推荐(表 1)。指南从 3 个维度确定推荐方向和强度:干预措施的效应量大小、针对合并结果的信心大小及价值观和偏好。此过程通过投票的方式来确定,投票小组成员匿名完成问卷调研,包括核心干预措施的选择及干预措施的强度及方向。在确定推荐方向(支持或反对)的前提下,推荐强度用投票的百分比表示。本指南中还针对某些补充性推荐内容或无直接证据支持的干预措施进行了“最佳临床实践声明”的定义。由指南核心小组和投票小组在完成前面的推荐意见投票工作后进行讨论,对于那些没有直接文献证据或者以作为补充性推荐的干预措施进行声明,在现有已推荐干预措施的基础上提供必要的补充性治疗意见。

3.5 资助情况

该指南声明在制订过程中仅受到了 OARSI 学会的直接资助,而没有接受来自其他商业机构的资助。

3.6 利益冲突

该指南的利益冲突中提到在指南制订过程中所有成员均进行了利益冲突声明。存在利益冲突

表 1 基于投票结果确定推荐级别和推荐强度

推荐级别	支持率 (%)	反对率 (%)	推荐强度占比 (%)
1A	75 ~ 100	0 ~ 25	>50%, 强推荐
1B	75 ~ 100	0 ~ 25	>50%, 弱推荐
2	60 ~ 74	26 ~ 40	默认弱推荐
3	41 ~ 59	41 ~ 59	默认弱推荐
4B	26 ~ 40	60 ~ 74	默认弱不推荐
4A	0 ~ 25	75 ~ 100	>50%, 弱不推荐
5	0 ~ 25	75 ~ 100	>50%, 强不推荐

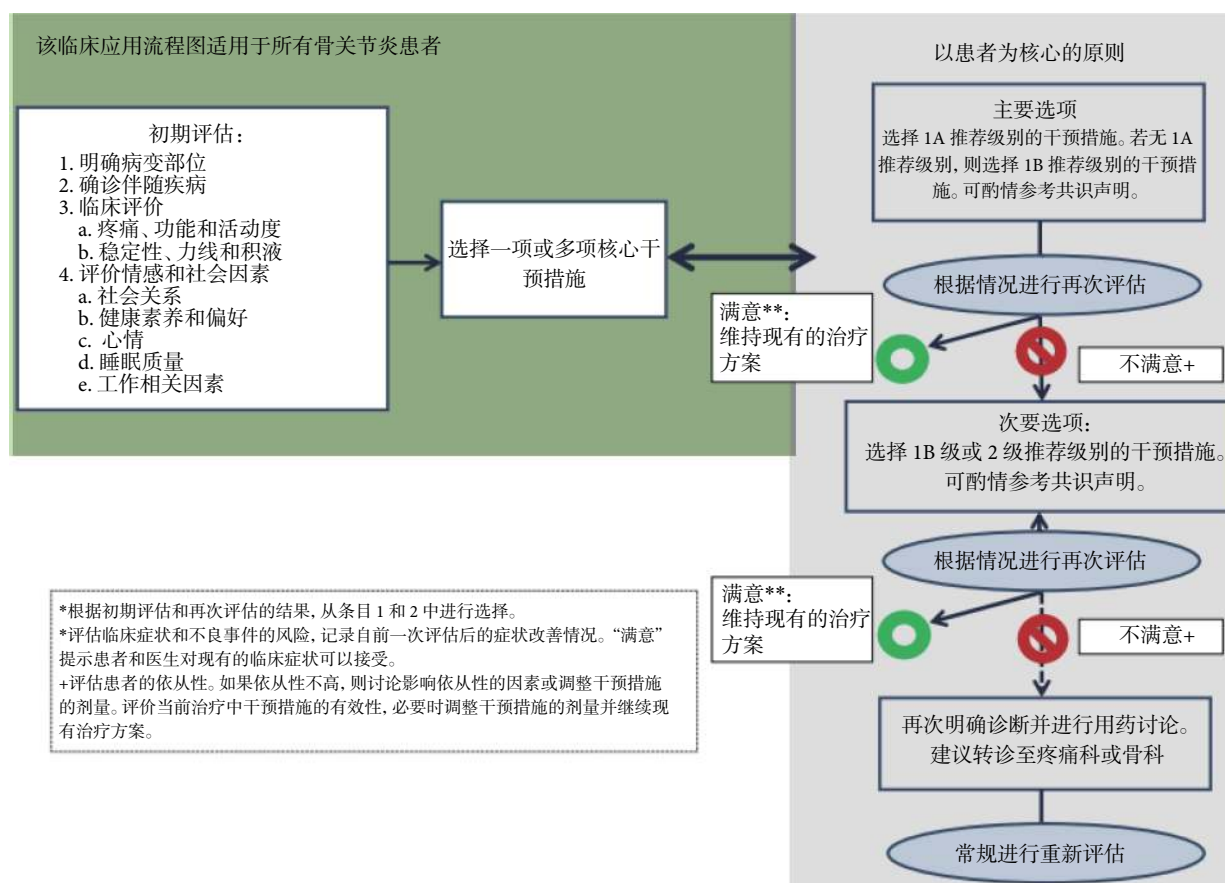


图1 OA诊疗临床路径图

的人员已经被排除在指南制订工作之外，现有的全部成员不存在利益冲突。

4 推荐意见及其相关内容

4.1 推荐意见概况

该指南通过临床路径图和表格的方式阐述了OA的治疗流程及不同干预措施在治疗膝、髋及多关节OA中的推荐方向和强度。这也是该指南区别于以往指南最大的改变。

4.2 临床路径图（图1）

该指南突出了以患者为核心的原则。通过对患者的反复评价，不断做出新的推荐或维持原有推荐。既反映了OA动态进展和干预的特点，也反应了以个性化干预和“以患者为核心”的指南特色。

在该临床应用路径图中，患者的评估过程主要分为两步：①基于OA的发病部位、伴随疾病及治疗目标及预期确定干预的路径；②评价影响干预强度及患者依从性的临床特点、情感特征及环境因素。在最初评估时，需要根据患者的需求和偏好制订合适的核心治疗方案。同时，还可根据患者的个性化特点给予1A（强推荐）和1B（弱推荐）的治疗干预。通常，建议医生在选择核心推荐意见时优先

联合强推荐干预措施，当无强推荐措施存在时联合弱推荐干预措施。在对患者进行初次干预后，需要再次评估患者，以考察干预措施的有效性、患者的依从性，并以此为依据调整干预措施的剂量或强度。如果患者在应用上述推荐干预措施后仍没有得到很好的改善，则建议选择其他的干预措施、寻求多学科疼痛治疗或接受手术治疗。

4.3 针对膝OA的推荐意见（表2）

4.3.1 核心推荐 包括：陆地训练、体重控制联合运动、身心运动（瑜伽、太极）、教育。可与其他干预措施联合或单独使用。

4.3.2 强推荐（1A） 包括：外用NSAIDs（适用于合并或未合并胃肠疾病、心血管疾病以及年老体弱的患者）。

4.3.3 弱推荐（1B和2） 包括：水中运动、步态辅助、患者自我管理、认知行为训练（适用于合并或未合并胃肠疾病、心血管疾病、年老体弱及全身广泛性疼痛的患者）；口服NSAIDs（适用于无上述合并症者）；口服COX-2抑制剂或非选择性NSAIDs联合质子泵抑制剂（适用于合并胃肠疾病以及全身广泛性疼痛者），针对高风险的患者（如年老体弱）建议低剂量、短疗程使用；关节腔注射

透明质酸、激素(适用于全部的膝 OA 患者), 其中激素缓解的疼痛效果持续时间较短, 透明质酸持续时间可能超过 12 周且安全性较高^[15]; 度洛西汀(适用于合并全身性疼痛或抑郁的患者, 针对这类患者还建议参考多学科疼痛管理)。

4.4 针对髌 OA 的推荐意见 (表 3)

4.4.1 核心推荐 包括: 陆地训练和教育。可与其他干预措施联合或单独使用。

4.4.2 强推荐 (1A) 无。

4.4.3 弱推荐 (1B 和 2) 包括: 身心运动(瑜伽、太极)、步态辅助(不适用于合并全身广泛性疼痛的患者)、患者自我管理; 认知行为训练(适用于合并全身广泛性疼痛的患者); 口服 COX-2 抑制剂或非选择性 NSAIDs 联合质子泵抑制剂(适用

于合并胃肠疾病以及全身广泛性疼痛者), 针对高风险的患者(如年老体弱)建议低剂量、短疗程使用。

4.5 针对多关节 OA 的推荐意见 (表 4)

4.5.1 核心推荐 包括: 陆地训练和教育。可与其他干预措施联合或单独使用。

4.5.2 强推荐 (1A) 无。

4.5.3 弱推荐 (1B 和 2) 包括: 身心运动(瑜伽、太极)、步态辅助(不适用于合并全身广泛性疼痛的患者)、患者自我管理; 体重控制联合或不联合运动(不适用于年老体弱者); 认知行为训练(适用于合并全身广泛性疼痛者); 口服 COX-2 抑制剂或非选择性 NSAIDs 联合质子泵抑制剂(适用于无合并症或全身广泛性疼痛者); 针对胃肠合并症

表 2 针对膝 OA 的推荐意见

推荐级别	推荐强度	干预类型	无合并症	合并胃肠疾病	合并心血管疾病	年老体弱	伴有全身疼痛或抑郁
核心推荐	强推荐		陆地训练、体重控制、教育				
1A 级 (≥ 75% 支持)	强推荐	药物干预	外用 NSAIDs	外用 NSAIDs		外用 NSAIDs	请参考 1B 级推荐
		非药物干预	请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐		请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐
1B 级 (≥ 75% 支持且 >50% 弱推荐)	弱推荐	药物干预	非选择性口服 NSAIDs、非选择性口服 NSAID+质子泵抑制剂、COX-2 抑制剂、关节腔注射激素	COX-2 抑制剂、关节腔注射激素或透明质酸	关节腔注射激素或透明质酸	关节腔注射激素或透明质酸	非选择性口服 NSAIDs、非选择性口服 NSAID+质子泵抑制剂、COX-2 抑制剂
		非药物干预	水中运动、步态辅助、患者自我管理	水中运动、步态辅助、患者自我管理		水中运动、步态辅助、患者自我管理	水中运动、步态辅助、患者自我管理、认知行为治疗联合运动
2 级 (60% ~ 74% 支持)	弱推荐	药物干预	关节腔注射透明质酸	非选择性口服 NSAID+质子泵抑制剂			度洛西汀、关节腔注射激素或透明质酸、外用 NSAIDs
		非药物干预	认知行为治疗联合运动	认知行为治疗联合运动		认知行为治疗联合运动	无
共识	弱推荐	其他	关节腔注射治疗	关节腔注射治疗、低剂量短疗程使用 NSAID		关节腔注射治疗、低剂量短疗程使用 NSAID	疼痛管理、关节腔注射治疗

表 3 针对髌 OA 的推荐意见

推荐级别	推荐强度	干预类型	无合并症	合并胃肠疾病	合并心血管疾病	年老体弱	伴有全身疼痛或抑郁
核心推荐	强推荐		陆地训练和教育				
1A 级 (≥ 75% 支持)	强推荐	药物干预	请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐		请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐
		非药物干预	请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐		请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐
1B 级 (≥ 75% 支持且 >50% 弱推荐)	弱推荐	药物干预	非选择性 NSAIDs	COX-2 抑制剂	请参考 2 级推荐	请参考 2 级推荐	请参考 2 级推荐
		非药物干预	身心运动、步态辅助、患者自我管理	身心运动、步态辅助、患者自我管理		身心运动、步态辅助、患者自我管理	身心运动、步态辅助、患者自我管理
2 级 (60% ~ 74% 支持)	弱推荐	药物干预	非选择性 NSAID+质子泵抑制剂、COX-2 抑制剂	非选择性 NSAID+质子泵抑制剂	无	无	非选择性 NSAIDs、非选择性 NSAID+质子泵抑制剂、COX-2 抑制剂
		非药物干预	无	无		无	认知行为训练、患者自我管理
共识	弱推荐	其他	体重控制	体重控制、低剂量短疗程使用 NSAID		低剂量短疗程使用 NSAID	疼痛管理、体重控制、低剂量短疗程使用 NSAID

者建议使用选择性 NSAIDs 或非选择性 NSAIDs 联合质子泵抑制剂；针对高风险的患者（如年老体弱）建议低剂量、短疗程使用；外用 NSAIDs（不适用于全身广泛性疼痛或抑郁者）；多关节使用 NSAIDs 需要注意超剂量使用的问题；可参考多学科疼痛管理控制疼痛。

4.6 强烈反对的推荐意见

该指南的附录中阐述了弱不推荐和强不推荐的相关内容。由于篇幅所限，本解读文章仅对常见的强不推荐干预措施进行举例，包括：阿片类透皮贴、口服阿片类药物、口服硫酸氨基葡萄糖、双磷酸盐、关节腔内注射干细胞和针灸等。然而，该指南对部分干预措施进行不推荐时是有一定前提的，如仅针对某些发病部位或伴随疾病类型进行不推荐。因此，建议临床工作者仔细查阅该指南的相关

附录获取具体应用条件。

4.7 部分推荐意见在指南间的比较

目前只有《AAOS 非手术治疗膝 OA 临床实践指南》是按照膝 OA 患者是否伴有合并症以及是否伴有多关节 OA 进行了推荐意见的说明。在这方面，OARSI 指南与其有一定的相似性。因此，笔者对比了涉及膝 OA 的部分推荐意见在上述两部指南中的差异（表 5）。两部指南都定义了核心推荐意见，其中陆地训练、体重控制与教育是两部指南共有的核心推荐意见，AAOS 指南进一步将水中运动和力量训练列为核心推荐意见。

4.8 推荐意见的参考文献

该指南正文和附录中并未详细列出了每条推荐意见涉及的全部参考文献、文献的质量等级以及最终纳入指南考虑的文献和排除的文献。

表 4 针对多关节 OA 的推荐意见

推荐级别	推荐强度	干预类型	无合并症	合并胃肠疾病	合并心血管疾病	年老体弱	伴有全身疼痛或抑郁
核心推荐	强推荐		陆地训练和教育				
1A 级（≥75% 支持）	强推荐	药物干预	请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐		请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐
		非药物干预	请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐		请参考 1B 级推荐	请参考 1B 级推荐
1B 级（≥75% 支持且>50% 弱推荐）	弱推荐	药物干预	非选择性 NSAIDs、外用 NSAIDs	COX-2 抑制剂	请参考 2 级推荐	请参考 2 级推荐	请参考 2 级推荐
		非药物干预	身心运动、患者自我管理、步态辅助、体重控制	身心运动、患者自我管理、步态辅助、体重控制		身心运动、患者自我管理、步态辅助、体重控制	认知行为治疗、患者自我管理、步态辅助、体重控制
2 级（60% ~ 74% 支持）	弱推荐	药物干预	非选择性 NSAID+质子泵抑制剂、COX-2 抑制剂	非选择性 NSAID+质子泵抑制剂、外用 NSAIDs	外用 NSAIDs	外用 NSAIDs	非选择性 NSAID、非选择性 NSAID+质子泵抑制剂、COX-2 抑制剂
		非药物干预	无	无		无	无
共识	弱推荐	其他	无	低剂量短疗程使用 NSAID		低剂量短疗程使用疼痛管理 NSAID	

表 5 OARSI 与 AAOS 指南在膝 OA 中部分主要推荐意见的比较

干预措施	AAOS		OARSI	
	无合并症	有合并症	无合并症	有合并症
外用 NSAID	适用	适用	强推荐	强推荐
非选择性 NSAID	适用	不确定（合并中度合并症风险）、建议联合质子泵抑制剂、不适应（合并高度合并症风险）	弱推荐	弱推荐（合并胃肠疾病）、建议联合质子泵抑制剂、不推荐（合并心血管疾病）
COX-2 抑制剂	适用	不确定（合并中度合并症风险）、不适应（合并高度合并症风险）	弱推荐	弱推荐（合并胃肠疾病）、不推荐（合并心血管疾病）
阿片类透皮贴	不确定	不确定	不推荐	不推荐
口服阿片类药物	不确定	不确定	不推荐	不推荐
口服对乙酰氨基酚	适用	不确定	不推荐	不推荐
氨基葡萄糖	不确定（对于缓解症状） 不适用（对于改变病情）	不确定（对于缓解症状）、不适用（对于改变病情）	不推荐	不推荐
关节腔注射激素	适用	适用	弱推荐	弱推荐
关节腔注射透明质酸	不确定	不确定	弱推荐	弱推荐
度洛西汀	适用	不确定	弱推荐（伴全身疼痛或抑郁）	弱推荐（伴全身疼痛或抑郁）

4.9 图表

该指南正文及附件中的推荐意见、结局指标的
证据质量等级等通过图表的方式进行呈现。

4.10 推荐意见的外审

推荐意见的外审环节包括两个部分：① 同行
评议；② 公众评议。该指南未报告指南外审相关
内容。

4.11 指南更新

由于现行指南是根据现有的循证医学证据制
订的，随着证据的不断积累及新技术的提出，指南
的内容需要更新。该指南是对 2014 年 OARSi 指南
的更新，尽管该版本指南未在文中报道更新的计划
和时间，但 OARSi 会定期对指南进行更新。

4.12 指南的传播、实施和评价

在指南的正式实施过程中，为增加指南的实用
性和应用性，OARSi 对主要推荐意见及应用的环境
进行了必要的解释。必要的解释有利于帮助指南
的使用者根据不同的临床情景作出正确的应用。
然而，该指南并未制订详细的指南传播计划和传播
途径。

指南的后效评价有利于反应指南的应用和实
施效果，但该指南工作组尚未针对该指南制订合理
的后效评价方案。我们认为，必要的指南后效评价
是更新指南、加快指南传播以及指南推广与应用的
依据和基础。制订切实可行的后效评价方案，及时
开展指南的后效评价，有助于未来指南的更新以及
推荐内容的修正，从而最终增加指南的实践性和实
用性。

4.13 优势和局限性

4.13.1 优势 在 OARSi 发布的各版本指南中，其
指南制订采用的方法学是不断进步的。该版指南
创新性地建立了以患者为核心理念的指南制订方
法，在获取临床问题后对现有的系统评价或 Meta
分析进行更新。一方面强调了对患者的动态评估
过程，另一方面也反应了选择不同干预措施的强
弱态度。该指南加入了患者参与的内容，包括了患
者意愿调查的结果，有利于了解患者对于干预措施
的偏好和价值观。另外，该指南附录中还包括：详
细的检索策略、PICO 问题、结局指标、证据总结
表等。该指南的上述优势，最终会增加指南的实用
性和转化价值。该版本 OARSi 指南制订方法的流
程见图 2。

4.13.2 局限性 该指南的全文中仅包括了主要的
推荐意见及相关解释，缺少对于不推荐意见的解
释和说明。而这些说明应该包括证据检索的情况、证

据评价的结果、共识形成的过程等。附录中缺少被
排除的研究及原因，因此无法明确指南制订者证据
的选择过程以及透明性（包括：是否考虑到了证据
的发表偏倚、证据的利益冲突、证据的选择性偏倚
等）。缺少指南计划书的公开与授权发布，可能影
响指南制订过程的透明性和结果的可信度。指南
的注册和计划书是为了提高指南制订的透明性和
可监督性，缺少相关内容会导致指南制订过程受内
在或外在因素的影响。

5 对我国临床实践和指南制订的意义

5.1 对临床实践的意义

OA 作为一种退行性全身性疾病目前无有效的
根治手段，除晚期需要手术干预外，前期的非手术
治疗手段很多，且缺少有效明确的临床指引。现有
关于 OA 的指南较多，也提示了现有指南的应用和
传播性可能不高^[16]。因此，在 OA 非手术治疗中需
要一部规范化的临床实践指南提供指引。该指南
强调以患者为中心，从伴随疾病类型入手区分不
同的患者特征，从而确定了不同干预措施的推荐强
度和推荐方向。该指南为 OA 非手术治疗提供了帮
助，具有一定的临床实践意义。

从我国 OA 的临床诊治角度看，该指南中推荐
或反对的干预措施都是临床工作中常见的治疗方
案。因此，该指南内容可以直接给与我国医生相关
指导，并提示我国医师应该学会站在以患者为中
心的视角及阶梯治疗的高度选择干预措施。同时，
在进行临床实践时，医师要根据患者具体情况权衡
干预措施的利弊大小，从而进行最终决策。

5.2 对指南制订的意义

解读指南的作用包括：① 指南方法学的传
播：通过指南的解读可以更好认识一部指南的方
法学优势与不足，为未来我国指南的制订工作提
供方法学支持；② 有利于指南的传播和改编：西
方国家的指南可以在基于本国国情的条件下进行
传播或改编，方便我们利用现有全球的高质量证
据指引我国的临床实践发展。

5.3 对临床研究的意义

该指南在推荐意见产生过程中同时指出了证
据不充分或无有效证据的干预措施类型。为未来
开展相应的原始临床研究提供方向性指引。

6 其他

6.1 OARSi 与 WHO 临床实践指南制订方法对比

全球范围内，目前有多个制订 OA 临床循证指

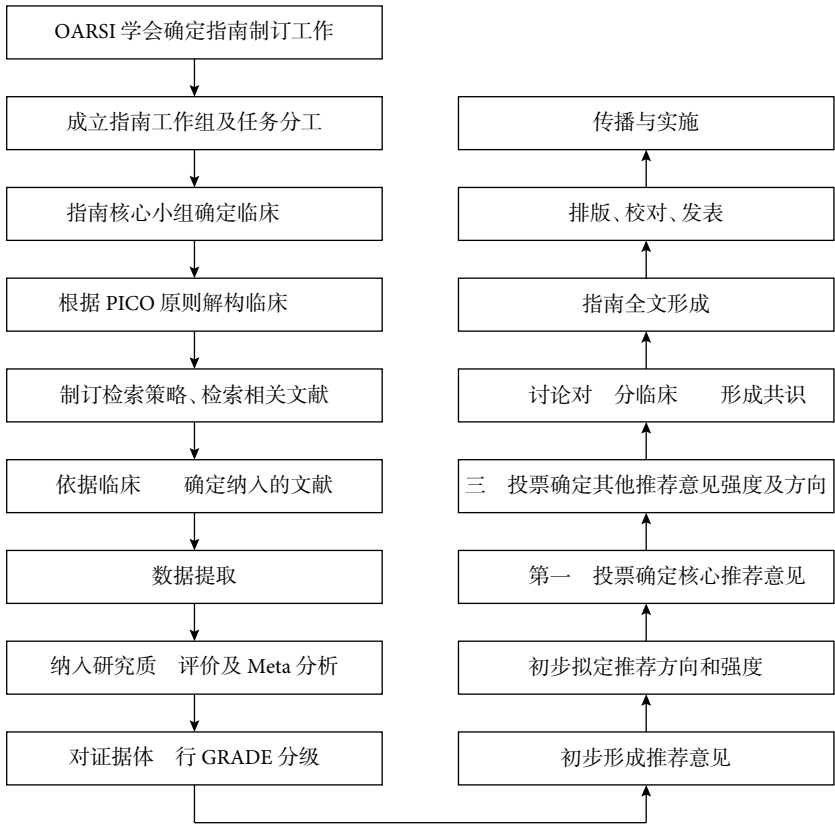


图2 2019年OARSIS指南方法学流程

表6 OARSIS与WHO指南在主要方法学步骤方面的差异

主要方法学条目	WHO 指南	OARSIS 指南
构建指南小组	通常需要四个团队：指导委员会、指南制订小组、外部评审小组以及系统综述小组。	主要包括：指南核心小组、文献综述小组、投票小组、患者小组。
指南计划书的撰写	需要撰写计划书，通过指南指导委员会批准后正式实施指南制订。	指南全文中尚未提及指南计划书的撰写。
证据检索和综合	基于当前最佳可得证据，采用严格的系统综述作为证据支持；检索时首先确认是否有相关的系统综述，或通过更新系统评价及制作新的系统评价进行证据总结和评价。	根据初步形成的临床问题制订检索策略、检索文献；根据临床问题匹配文献并纳入研究，进行下一步的Meta分析。
证据评价	采用GRADE方法 ^[18] 评价证据体的质量，从而形成推荐意见；评价过程由GRADE方法学家完成；基于高质量的回溯性研究的证据体GRADE评级可能较高，因此可能被用作指南推荐意见形成的重要证据。	采用GRADE方法评价证据体的质量，从而形成推荐意见；评价过程由文献综述小组完成。
制订推荐意见	除考虑证据体的质量外，还考虑患者的偏好与价值观、成本-效益因素、资源利用因素等；在形成推荐意见时，要分别考虑推荐意见的方向和强度。	在形成初步推荐意见后开展了多轮投票环节，此环节的目的是参考临床实践者的偏好、价值观以及临床经验等。

南的机构或者组织，包括国家卫生组织（WHO）、美国骨科医师学会（AAOS）、英国国家卫生和临床技术优化研究所（NICE）以及加拿大渥太华指南制订机构（Ottawa）等。在临床实践指南的制订方法方面，OARSIS与WHO或NICE指南存在一定的差别。现以WHO指南制订方法^[17]为例，对比OARSIS和WHO在主要方法学步骤方面的差异（表6）。

6.2 本解读的局限性

本文对2019年《OARSIS非手术治疗膝、髋及多关节骨关节炎临床实践指南》的方法学内容进

行了重点的解释和分析，不仅包括了该指南方法学的描述，而且对主要的方法学步骤进行了评述。由于该领域涉及的相关干预措施较多，本解读文章没有对全部干预措施的推荐意见内容进行详细解读。因此，针对临床推荐意见方面的内容可能还需要读者参考该指南正文和附属性文件。此外，目前针对临床实践指南的专业解读文章较少，所以本文对于指南解读的报告内容和方法缺少公认的方法学支持。因此，可能在结果指南的过程中针对某些环节存在疏漏。笔者认为，随着国内外临床实践指

南发表数量的增多, 指南的解读类文章数量势必随之增加, 因此需要制订标准化的解读规范为后人提供指导。

参考文献

- McAlindon, TE, Bannuru, RR, Sullivan, MC, *et al.* OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage*, 2014, 22(3): 363-388.
- Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, *et al.* OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. *Osteoarthritis Cartilage*, 2008, 16(2): 137-162.
- Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, *et al.* OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage*, 2019, 27(11): 1578-1589.
- Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. *Lancet*, 2011, 377(9783): 2115-2126.
- Tang X, Wang S, Zhan S, *et al.* The prevalence of symptomatic knee osteoarthritis in China: results from the China health and retirement longitudinal study. *Arthritis Rheumatol*, 2016, 68(3): 648-653.
- Zhang JF, Song LH, Wei JN, *et al.* Prevalence of and risk factors for the occurrence of symptomatic osteoarthritis in rural regions of Shanxi Province, China. *Int J Rheum Dis*, 2016, 19(8): 781-789.
- Kang X, Fransen M, Zhang Y, *et al.* The high prevalence of knee osteoarthritis in a rural Chinese population: the Wuchuan osteoarthritis study. *Arthritis Rheum*, 2009, 61(5): 641-647.
- Cross M, Smith E, Hoy D, *et al.* The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the global burden of disease 2010 study. *Ann Rheum Dis*, 2014, 73(7): 1323-1330.
- Hermans J, Koopmanschap MA, Bierma-Zeinstra SM, *et al.* Productivity costs and medical costs among working patients with knee osteoarthritis. *Arthritis Care Res (Hoboken)*, 2012, 64(6): 853-861.
- Hunter DJ, Schofield D, Callander E. The individual and socioeconomic impact of osteoarthritis. *Nat Rev Rheumatol*, 2014, 10(7): 437-441.
- Le Pen C, Reygrobelle C, Gérentes I. Financial cost of osteoarthritis in France. The "COART" France study. *Joint Bone Spine*, 2005, 72(6): 567-570.
- Kingsbury SR, Gross HJ, Isherwood G, *et al.* Osteoarthritis in Europe: impact on health status, work productivity and use of pharmacotherapies in five European countries. *Rheumatology (Oxford)*, 2014, 53(5): 937-947.
- Sharif B, Garner R, Hennessy D, *et al.* Productivity costs of work loss associated with osteoarthritis in Canada from 2010 to 2031. *Osteoarthritis Cartilage*, 2017, 25(2): 249-258.
- Slavin RE. Best evidence synthesis: an intelligent alternative to meta-analysis. *J Clin Epidemiol*, 1995, 48(1): 9-18.
- Jevsevar D, Donnelly P, Brown GA, *et al.* Viscosupplementation for osteoarthritis of the knee: a systematic review of the evidence. *J Bone Joint Surg Am*, 2015, 97(24): 2047-2060.
- Johnston BC, Thorlund K, Schünemann HJ, *et al.* Improving the interpretation of quality of life evidence in meta-analyses: the application of minimal important difference units. *Health Qual Life Outcomes*, 2010, 8: 116.
- 丁泓帆, 杨楠, 邓围, 等. WHO 指南制定的基本原则和方法. *中国循证医学杂志*, 2016, 16(4): 471-477.
- Atkins D, Best D, Briss PA, *et al.* Grading quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*, 2004, 328(7454): 1490.

收稿日期: 2019-09-28 修回日期: 2019-12-31

本文编辑: 熊鹰